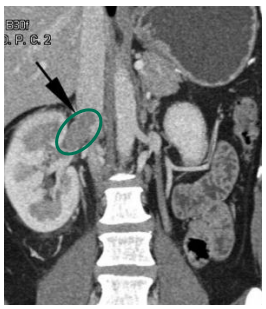
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

六、肾病综合征



（一）并发症（感染鸡蛋血-不要推）

1.**血栓及栓塞** ①免疫复合物/自身抗体损伤血管内皮C ②肝脏代偿合成脂蛋白 ③抗凝纤溶系统失衡

①最常见于**膜性肾病**

不通则痛

②最常累及**肾静脉**——**突发腰痛、血尿或蛋白尿加重、肾功能减退、肾脏** ttsx **增大**

还可累及下腔静脉、下肢血管、肺血管、冠状血管、脑血管

复习：肝硬化门静脉血栓形成——腹痛、腹水迅速增加、脾迅速增大

③**首选 B 超**，最佳肾静脉造影

低白蛋白血症(白蛋白<30)

④**白蛋白＜20**g/L：**预防性抗凝**（如肝素或华法林）、辅以抗血小板（如阿司匹林或双嘧达莫）

已发生血栓及栓塞还需溶栓（如阿替普酶）静脉内主要是血液凝固,故基本治疗一定是抗凝

干扰选项

2.**蛋白质及脂代谢紊乱**（不是水电解质代谢紊乱）：**肝代偿增加**蛋白合成的能力＜丢失和分解

3.**感染**：无需预防性用抗生素。一旦感染及时用半合成青霉素、头孢、喹诺酮，若感染难控制可减少或停用激素

VS尿路感染常用抗生素(肾毒性小)　尿黄莫偷窥啊

4.**急性肾损伤**（不是慢性肾衰竭）：最常见于**脂性肾病** amazing　60岁之后的脂性肾病

zhi

（二）治疗

避免反跳现象

1.**主要治疗——糖皮质激素：起始足量（泼尼松每天 1mg/kg、8-12 周），缓慢减量，长期维持（半年）**

2.免疫抑制剂：**常用环磷酰胺**（细胞毒性药环球）；对于激素+环磷酰胺无效的难治性肾病综合征可用环孢素、吗替麦考酚酯（环抱麦芬）

原发性肾小球疾病

炎症性肠病常用免疫抑制剂:硫唑嘌呤、巯嘌呤,不耐受者用甲氨蝶呤

注意：不同肾病综合征的病理类型对激素治疗的反应性不同

①**脂性肾病**（最敏感）、**系膜增生性肾炎**、**局灶节段性肾小球硬化**：在**初治**时**单用激素**即可，因为它们常属于激素敏感型（自己吸激）。如肾病综合征用 4 周泼尼松后复查尿蛋白+++→**继续原剂量治疗**；**8 周后无效再加环磷酰胺**

②**膜性肾病**、**系膜毛细血管性肾炎**（疗效差）：在初治时用激素+环磷酰胺，因为它们常属于激素依赖型或抵抗型

③所有肾病综合征在**复治**时均应用**激素+环磷酰胺**

3.其它治疗

①**ACEI/ARB、SGLT2i 减少尿蛋白排泄**

②利尿消肿、低盐（＜2g/d）

③**不**主张摄入高蛋白 持续尿蛋白、持续高血压会损害肾单位

④严重低蛋白血症、低血容量可**少量输白蛋白**以提高血浆胶渗压 不会常规输白蛋白

（三）原发性肾病综合征

T细胞的细胞免疫

1.**脂性肾病**（踢足球的小子脏）脂肪变性(只发生在细胞内):心肌骨骼肌

（1）名字 不是体液免疫就没有免疫复合物,就不会有荧光,就不会有电子致密物

①**脂性肾病**：**近**端小管**脂肪变性**，切面肾皮质出现黄白色条纹

②**足突病**：肾小囊**脏**层上皮细胞（**足细胞**）**足突融合消失**

说明脂性肾病只有电荷屏障损害,没有机械屏障损害

所以只有选择性蛋白尿

③**微小病变性肾病**：儿童、青年多见（**儿童最常见的肾病综合征**）；**光镜**下肾小**球无**明显异常

微小:①年龄②光镜下肾小球无异常改变,只看到近端小管脂肪变性　VS 光镜下肾小管有异常:脂肪变性